

Czym jest *depresja*

Nie „chwilowe załamanie”. Konkretnie zaburzenie z kryteriami. ~7–10 % populacji w ciągu roku, 17 % w całym życiu.

CZAS: 15 min · psychoedukacja 1 sesja **ŹRÓDŁO:** APA DSM-5-TR (2022); WHO ICD-11 (2022); NICE NG222

JAK UŻYWAĆ

Przeczytaj **kryteria DSM-5-TR i ICD-11** (sekcja 01). Zaznacz, które rozpoznajesz u siebie (sekcja 02). Sprawdź, kiedy szukać pomocy **natychmiast** (czerwone flagi w sekcji 03). To *nie* jest autodiagnoza — to mapa do rozmowy z terapeutą lub lekarzem. Formalna diagnoza wymaga wywiadu klinicznego.

DLACZEGO TO DZIAŁA

Pacjent z depresją często myśli: „*jestem słaby/-a*”, „inni mają gorzej, nie powinienem się skarżyć”, „to mój charakter”. To **kluczowe zniekształcenie podtrzymujące**. Otrzymanie etykiety diagnostycznej działa terapeutycznie z trzech powodów: (1) *normalizuje* — 1 na 6 osób w ciągu życia, nie jesteś sam, (2) *zdejmuje wstyd* — to zaburzenie z mechanizmem, nie moralna porażka, (3) *otwiera drogę do leczenia* — istnieją skuteczne protokoły: CBT, BA, IPT, farmakoterapia (SSRI, SNRI). Etykieta *nie* ma stać się tożsamością — ma być **punktem wyjścia**.

01 Kryteria diagnostyczne

DSM-5-TR (EPIZOD DEPRESYJNY F32.X)

A. ≥5 z 9 objawów przez **≥2 tyg.**, w tym przynajmniej jeden z dwóch pierwszych:

1. **obniżony nastrój** większość dnia
2. **anhedonia** (utrata zainteresowań / przyjemności)
3. zmiana masy ciała / apetytu (±5 % / mies.)
4. bezsenność / nadmierna senność
5. pobudzenie / spowolnienie psychoruchowe
6. zmęczenie / utrata energii
7. poczucie bezwartościowości / nadmiernej winy
8. trudność z koncentracją / decyzjami
9. nawracające myśli o śmierci / suicydalne

B. Cierpienie / pogorszenie funkcjonowania.

C. Nie wynika z substancji / choroby.

ICD-11 (6A70.X)

Wymaga **≥2 tyg.** obecności objawów rdzeniowych:

1. **obniżony nastrój**
2. **utrata zainteresowań**
3. **utrata energii / męczliwość**

Plus objawy dodatkowe: zaburzenia uwagi, samoocena, samokrytyka, beznadzieja, myśli suicydalne, zaburzenia snu, zmiany apetytu.

Stopnie:

- **łagodny** — funkcjonowanie zachowane z trudem
- **umiarkowany** — wyraźne pogorszenie
- **ciężki** — niemożność funkcjonowania

Różnica vs DSM: ICD-11 mocniej akcentuje 3 rdzeniowe + stopniowanie, DSM-5 — listę 9 objawów z progiem 5/9.

02 Lista samosprawdzenia — przez ostatnie 2 tyg.

- ☐ **Obniżony nastrój** większość dnia, prawie codziennie
- ☐ **Zmęczenie** bez powodu — nie regeneruję się snem
- ☐ Zmiana **apetytu / masy ciała** ($\pm$)
- ☐ Trudność z **koncentracją** / podejmowaniem decyzji
- ☐ Myśli o **śmierci** / samobójstwie
- ☐ **Utrata zainteresowań** — nic nie cieszy jak kiedyś
- ☐ **Bezsenna** / wczesne pobudki / nadmierna senność
- ☐ **Spowolnienie** / pobudzenie ruchowe (zauważalne dla innych)
- ☐ Poczucie **bezwartościowości** / nieadekwatnej winy
- ☐ **Wycofanie** z aktywności, relacji, obowiązków

≥ 5 zaznaczeń (w tym 1 z pierwszych 2), trwają ≥ 2 tyg., wpływa na funkcjonowanie — warto skonsultować się ze specjalistą. To *nie* jest diagnoza — formalna wymaga wywiadu. Skali przesiewowe: PHQ-9 (cut-off ≥ 10), BDI-II (cut-off ≥ 14).

03 Czerwone flagi — szukaj pomocy NATYCHMIAST

-  **Konkretne myśli samobójcze** z planem
-  **Niemожność wykonania** podstawowych czynności (jedzenie, mycie)
-  **Sięganie po alkohol / leki** w ilościach ryzykownych
-  **Brak chęci życia** trwający dłużej niż kilka dni
-  **Objawy psychotyczne** — głosy, urojenia, depersonalizacja
-  **Depresja po porodzie** — z myślami o krzywdzeniu dziecka

Telefon zaufania (PL, 24/7): Centrum Wsparcia dla Osób w Stanie Kryzysu Psychicznego — **800 70 22 22** · Telefon Zaufania dla Dorosłych — **116 123** · Pogotowie — **112**.

Kluczowe fakty: ~7-10 % populacji rocznie, 17 % w ciągu życia (PL i światowe statystyki podobne). 2x częściej kobiety. Średni wiek pierwszego epizodu: 25-30 lat. *Skuteczne leczenie:* CBT, BA, IPT (40-60 % pełnej remisji po 12-16 sesjach); SSRI, SNRI; kombinacja CBT + lek = najsilniejsza (Cuijpers 2014, NNT $\approx$ 4). Depresja *współwystępuje* z lękiem (60 %), uzależnieniami (25 %), chorobami somatycznymi (cukrzyca, choroby serca — 30 %). **Im wcześniej leczenie, tym mniejsze ryzyko chronizacji.**